

Factores biológicos, psicológicos y sociales de la enfermedad mental

1. Introducción y relevancia clínica

El **modelo biopsicosocial** es el marco teórico y clínico que sustenta toda la práctica psiquiátrica contemporánea.

Fue propuesto por **George Engel (1977)** como una respuesta al modelo biomédico tradicional, que explicaba la enfermedad solo desde el cuerpo.

En psiquiatría, este enfoque reconoce que los **trastornos mentales** resultan de la **interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales**, que influyen en la **vulnerabilidad, aparición, evolución y recuperación** del paciente.

En Chile, las guías clínicas MINSAL y los programas **GES de salud mental** (depresión, esquizofrenia, bipolaridad, entre otros) están estructurados sobre este modelo, que busca integrar atención médica, psicoterapia y apoyo social.

□ En el **EUNACOM**, este tema aparece frecuentemente en preguntas de razonamiento clínico del tipo:

“Paciente con predisposición genética, estrés laboral y pérdida reciente desarrolla cuadro depresivo. Según el modelo biopsicosocial, ¿qué factor es el más modificable?”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El modelo biopsicosocial no propone una fisiopatología única, sino una **interacción dinámica** entre sistemas:

2.1. Factores biológicos

Abarcan los **procesos neurobiológicos, genéticos, endocrinos y fisiológicos** que predisponen o modulan la respuesta emocional y conductual.

Principales componentes:

Nivel	Ejemplos clínicos
Neuroquímico	Alteraciones en neurotransmisores: ↓ serotonina en depresión, ↑ dopamina en esquizofrenia, ↓ GABA en ansiedad.

Genético	Riesgo hereditario: esquizofrenia (40–80% heredabilidad), trastorno bipolar (60–70%).
Neuroendocrino	Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) hiperactivado en depresión y estrés crónico.
Inflamatorio	Incremento de citocinas proinflamatorias (IL-6, TNF- α) en depresión y esquizofrenia.
Estructural y funcional	Disfunción de corteza prefrontal y amígdala en trastornos del ánimo y ansiedad.

El **sustrato biológico** explica la vulnerabilidad y las manifestaciones clínicas, pero no determina por sí solo el desarrollo de una enfermedad.

2.2. Factores psicológicos

Corresponden a los **procesos mentales internos** que modulan cómo una persona percibe, interpreta y responde a su entorno.

Principales modelos psicológicos:

1. Psicodinámico (Freud, Klein):

- Conflictos inconscientes entre pulsiones y defensas del yo.
- Ejemplo: somatización como conversión de conflicto emocional reprimido.

2. Cognitivo-conductual (Beck, Ellis):

- Pensamientos automáticos disfuncionales generan emociones y conductas patológicas.
- Ejemplo: “Soy inútil” → tristeza → retraimiento social.

3. Aprendizaje y condicionamiento (Pavlov, Skinner):

- Fobias o adicciones como conductas aprendidas reforzadas positivamente o por evitación.

4. Factores de personalidad:

- Rasgos ansiosos, perfeccionistas o impulsivos aumentan riesgo de ansiedad, depresión o abuso de sustancias.

5. Mecanismos de defensa:

- Adaptativos (sublimación, humor) o patológicos (negación, proyección).

2.3. Factores sociales

Son los **determinantes contextuales y ambientales** que afectan la salud mental, tanto como los factores biológicos o psicológicos.

Dimensión	Ejemplos	Impacto clínico
Familia y apoyo social	Conflictos, violencia intrafamiliar, aislamiento	Predicen recaídas en esquizofrenia y depresión
Socioeconómico	Pobreza, desempleo, vivienda precaria	Asociado a depresión y abuso de sustancias
Educación	Bajo nivel educacional	Menor acceso a tratamiento y peor pronóstico
Eventos vitales	Pérdida, divorcio, migración, catástrofes	Desencadenan cuadros adaptativos o depresivos
Cultura	Normas, valores, religión	Modulan la expresión de síntomas (p. ej., somatización en culturas latinas)

□ En Chile, el MINSAL reconoce los **determinantes sociales de la salud mental** como prioritarios en la planificación sanitaria (Estrategia Nacional de Salud Mental 2021–2030).

2.4. Modelo de vulnerabilidad-estrés

Este modelo integra los tres niveles (biológico, psicológico y social).

Propone que una persona desarrolla enfermedad mental cuando una **vulnerabilidad predisponente** se combina con **factores estresores** que superan su capacidad adaptativa.

Ecuación conceptual:

Enfermedad mental = Vulnerabilidad biológica + Estrés ambiental ± Factores protectores

Ejemplo:

- Individuo con historia familiar de depresión (biológico)
- Personalidad dependiente (psicológico)
- Pérdida de empleo y aislamiento social (social)

→ Desencadena episodio depresivo mayor.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El modelo biopsicosocial se aplica a **todas las patologías psiquiátricas**, ya que orienta la **evaluación integral** del paciente.

3.1. Evaluación clínica integral

Debe incluir:

1. **Síntomas actuales:** estado de ánimo, ansiedad, conducta.
2. **Factores predisponentes:** historia familiar, traumas, personalidad.
3. **Factores precipitantes:** eventos recientes o consumo de sustancias.
4. **Factores perpetuantes:** aislamiento, falta de adherencia, pobreza.
5. **Factores protectores:** red de apoyo, religiosidad, estabilidad laboral.

3.2. Ejemplo clínico

Paciente de 42 años, mujer, presenta insomnio, tristeza y fatiga tras separación reciente.

- Antecedente familiar de depresión (biológico).

- Rasgos perfeccionistas (psicológico).
- Aislamiento y desempleo (social).

→ Diagnóstico: **Episodio depresivo leve (F32.0)**.

→ Enfoque de manejo: ISRS + psicoterapia + reinserción laboral.

3.3. Diagnóstico diferencial

El modelo biopsicosocial ayuda a diferenciar entre:

Tipo de cuadro	Características distintivas
Orgánico (biológico)	Déficit cognitivo, síntomas neurológicos, aparición brusca.
Reactivo (psicológico/social)	Relación temporal con evento vital, sin disfunción neuroquímica.
Mixto	Combinación de vulnerabilidad biológica y gatillantes psicosociales.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque el enfoque biopsicosocial es clínico, ciertos exámenes ayudan a evaluar los **componentes biológicos** o a descartar comorbilidades.

4.1. Exámenes biológicos

- Perfil tiroideo (T4, TSH).
- Cortisol plasmático o test de supresión con dexametasona (depresión endógena).
- Glicemia, lípidos y prolactina (control por psicofármacos).
- TAC o RM cerebral (sospecha de causa orgánica).

4.2. Evaluación psicológica

- Entrevistas estructuradas (MINI, SCID).
- Escalas psicométricas:
 - **Beck Depression Inventory (BDI).**
 - **Hamilton Anxiety Scale.**
 - **PANSS** (síntomas psicóticos).
 - **MMPI** (personalidad).

4.3. Evaluación social

- Aplicación de instrumentos de apoyo social (Duke-UNC, Apgar familiar).
 - Escala de eventos vitales (Holmes y Rahe).
 - Evaluación de red comunitaria y vulnerabilidad familiar.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo debe ser **integral y multimodal**, combinando intervención **biológica, psicológica y social**, según la gravedad y recursos del paciente.

5.1. Nivel biológico

- **Farmacoterapia:** ISRS, estabilizadores, antipsicóticos, ansiolíticos según diagnóstico.
- **Control de efectos secundarios** y educación sobre adherencia.
- **Tratamiento médico de comorbilidades.**

5.2. Nivel psicológico

- **Psicoterapia individual o grupal:** TCC, psicodinámica, interpersonal, familiar.
- **Psicoeducación:** explicar la naturaleza del trastorno, recaídas, adherencia.

- **Técnicas de manejo de estrés y relajación.**

5.3. Nivel social

- **Intervención familiar y comunitaria:** trabajo social, visitas domiciliarias, apoyo laboral.
- **Programas comunitarios de rehabilitación psicosocial (centros COSAM, CESFAM).**
- **Apoyo en red:** clubes de usuarios, grupos de autoayuda.

En Chile, el MINSAL promueve la **atención en red** y la **integración APS–especialidad**, enfatizando la continuidad de cuidados y el rol del equipo multidisciplinario.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Si el modelo no se aplica:

- Diagnóstico parcial centrado en síntomas sin contexto.
- Tratamientos farmacológicos inefectivos por no abordar causas psicosociales.
- Recaídas frecuentes, falta de adherencia o abandono.

6.2. Factores pronósticos positivos:

- Alta red de apoyo familiar.
- Acceso a tratamiento integral.
- Insight adecuado y adherencia.
- Educación y trabajo estable.

6.3. Factores pronósticos negativos:

- Estigmatización o exclusión social.
- Comorbilidad médica crónica.

- Historia familiar severa o consumo de sustancias.

Pronóstico general:

Mejor cuando se implementan estrategias integradas de tratamiento y seguimiento longitudinal.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **modelo biopsicosocial** integra los tres niveles de la experiencia humana.
 2. **Ningún factor actúa aisladamente:** biología, mente y contexto interactúan.
 3. El **modelo de vulnerabilidad-estrés** explica la aparición y recaídas.
 4. En Chile, este modelo guía el **Programa Nacional de Salud Mental (MINSAL)**.
 5. Siempre evaluar **factores protectores** (familia, empleo, espiritualidad).
 6. La **psicoterapia y el apoyo social** son tan importantes como el fármaco.
 7. En EUNACOM, se debe identificar cuál factor es **predisponente, precipitante o perpetuante**.
-



Errores comunes

- Reducir el diagnóstico a una causa “biológica” sin explorar contexto.
- Omitir historia familiar o consumo de sustancias.
- Descartar psicoterapia en cuadros leves o moderados.
- No incluir al entorno familiar en el plan terapéutico.

- Asumir que el tratamiento farmacológico basta para la recuperación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La enfermedad mental resulta de la interacción **biológica, psicológica y social**.
2. El modelo biopsicosocial es la base de la **psiquiatría moderna y del sistema GES chileno**.
3. Los **factores biológicos** determinan vulnerabilidad; los **psicosociales**, el gatillante y curso.
4. El **modelo de vulnerabilidad-estrés** integra predisposición y eventos vitales.
5. El manejo debe ser **integral**, combinando farmacoterapia, psicoterapia y apoyo social.
6. Aplicar este modelo **mejora adherencia, pronóstico y calidad de vida**.
7. En el EUNACOM, identificar correctamente **factores predisponentes, precipitantes y protectores** es clave para resolver casos clínicos.